Resumo Técnico do Histórico e Documentação Clínica

Análise integrada de 29 exames e prontuários médicos | Período: Junho a Outubro de 2026

Paciente Principal: Frederico (Bulldog Francês) | Paciente Secundária: Birt (Lhasa Apso) | Clínica: Pet com Pet

O conjunto documental reúne 29 laudos veterinários emitidos entre junho e outubro de 2026, compreendendo exames laboratoriais, microbiológicos, radiográficos, ultrassonográficos e histopatológicos. A quase totalidade dos registros (28 arquivos) documenta o diagnóstico, intervenção e recuperação do paciente Frederico (canino, Bulldog Francês, macho, filhote de 6 a 9 meses), além de um laudo avulso referente à paciente Birt (canina, Lhasa Apso, 9 anos).

1. Caso Clínico Principal: Frederico (Bulldog Francês)

A. Admissão e Diagnóstico Sindrômico (Julho – Agosto de 2026)

O paciente iniciou acompanhamento no final de julho apresentando ferida exsudativa em pata/membro pélvico e impotência funcional grave:

• Hematologia e Bioquímica Inicial (30/07): Quadro inicial crítico com bicitopenia intensa — anemia macrocítica hipocrômica/normocítica (hematócrito 22–24,8%, hemoglobina 7,2–7,6 g/dL) com presença de metarrubrócitos e anisocitose, associada a leucopenia acentuada (1.200 a 2.300 leucócitos/µL com neutropenia) e hiperproteinemia sérica (8,3 g/dL), indicativa de inflamação e consumo sistêmico grave.

• Exames de Triagem Geral (28/07): Ecocardiograma com Doppler preservado (sem cardiopatias estruturais) e ultrassonografia abdominal demonstrando órgãos parenquimatosos sem alterações morfológicas significativas, exceto discreta lama biliar.

• Diagnóstico por Imagem (04/08 e 22/08): As radiografias do membro pélvico direito (MPD) revelaram osteomielite destrutiva agressiva em fêmur direito, caracterizada por arqueamento e encurtamento diafisário, extensa lise cortical entremeada por esclerose, desorganização medular, luxação coxofemoral secundária e reação periosteal exuberante com formação de sequestros ósseos. No tórax, evidenciou-se padrão pulmonar intersticiobronquial associado a focos alveolares cranioventrais.

B. Microbiologia e Perfil Antimicrobiano

• Cultura de Secreção (30/07): Isolamento polimicrobiano de Enterococcus sp. e Klebsiella pneumoniae. Apresentou padrão multirresistente (resistência a cefalosporinas, quinolonas, sulfas e clindamicina), demonstrando suscetibilidade à ampicilina/amoxicilina (Enterococcus) e amicacina/neomicina (Klebsiella). A hemocultura seriada (11/08) foi negativa, descartando bacteremia persistente.

• Recidiva em Lesão Cutânea (12/09): Isolamento de Proteus sp. em nova secreção de ferida em perna, direcionando a adequação terapêutica conforme antibiograma específico.

C. Intervenção Cirúrgica e Laudo Histopatológico

Diante do comprometimento ósseo irreversível e risco séptico, indicou-se a amputação terapêutica do MPD por desarticulação coxofemoral em 28/08/2026. O exame histopatológico (PAT 7323-26) confirmou periosteíte piogranulomatosa e esclerosante multifocal moderada, com proliferação fibroblástica reativa e ausência de atipias neoplásicas, selando o diagnóstico definitivo de osteomielite infecciosa crônica.

D. Evolução Pós-Operatória e Monitoramento (Setembro – Outubro de 2026)

• Avaliação Ortopédica Pós-Cirúrgica (14/09): Radiografia de controle atestou coto de amputação íntegro e asséptico, articulação coxofemoral esquerda congruente e preservação óssea do membro contralateral e pelve.

• Recuperação Laboratorial: Hemogramas seriados demonstraram reversão sustentada da anemia e da leucopenia, com leucocitometria normalizada ao longo de setembro e outubro. As funções renal (ureia e creatinina basais) e hepática (ALT/albumina) mantiveram-se estáveis.

• Investigação Molecular (02/10): qPCR em tempo real para Babesia canis com resultado Não Detectado, afastando hemoparasitose como fator etiológico da anemia pregressa.

2. Caso Secundário: Birt (Lhasa Apso)

O documento de 05/06/2026 (PAT 4642-26) corresponde ao exame histopatológico de biópsia excisional múltipla:

• Glândula Mamária: Diagnóstico de carcinoma em tumor misto grau 1 (baixo índice mitótico, margens cirúrgicas livres porém profundas estreitas).

• Pele Hirsuta: Diagnóstico de melanoma melanocítico misto dérmico (90%).

Conclusão Técnica Integrada:

O histórico clínico de Frederico retrata o curso de uma osteomielite femoral grave por patógenos multirresistentes, acompanhada de colapso medular transitório. A intervenção cirúrgica de amputação, associada à antibioticoterapia guiada por cultura e monitoramento intensivo, resultou em resolução do foco infeccioso e plena recuperação clínica.